Преобладающая полярность для персонализированного лечения биполярного расстройства

10.08.2026 / Новости



В журнале *Current Psychiatry Reports* опубликован обзор концепции преобладающей полярности при биполярном расстройстве – устойчивой склонности заболевания протекать преимущественно с депрессивными или маниакальными эпизодами. Авторы показывают, что такая характеристика связана с различиями в возрасте дебюта, психотических симптомах, когнитивных исходах, а также может помогать точнее выбирать поддерживающую фармакотерапию и психосоциальные вмешательства. При этом сама концепция пока остаётся дискуссионной из-за отсутствия единого определения и сложности учёта смешанных эпизодов.

Биполярное расстройство представляет собой тяжёлое психическое заболевание, характеризующееся колебаниями настроения от маниакальных до депрессивных эпизодов. Отсутствие лечения или недостаточный контроль биполярного расстройства нередко приводит к значительным личным, социальным и

Идентификация клинических подтипов, ассоциированных с различными долгосрочными траекториями течения, является ключевым условием для развития прецизионных терапевтических подходов, а также формирования проактивных и превентивных стратегий.

В последние годы вновь возрос интерес к концепции преобладающей полярности – спецификатора течения биполярного расстройства, который отсутствует в действующих диагностических классификациях. Преобладающая полярность рассматривается как валидный эндофенотип биполярного расстройства и обеспечивает клинически значимую информацию для специалистов.

Концепция преобладающей полярности была предложена для выделения подгрупп пациентов, у которых рецидивы преимущественно относятся к депрессивным либо к маниакальным эпизодам. Со временем были разработаны несколько операциональных определений для более точного описания фенотипов в рамках одной диагностической категории. Согласно этим определениям, депрессивная преобладающая полярность выявляется у 35-50% пациентов, тогда как маниакальная преобладающая полярность – у 55%. Разные варианты преобладающей полярности ассоциированы с различными фенотипами биполярного расстройства, и их выделение может способствовать персонализации психофармакологической терапии.

Несмотря на широкое использование, определение преобладающей полярности остаётся дискуссионным. Одно из ключевых возражений заключается в том, что математический принцип ее определения не полностью отражает клинические нюансы фенотипов, особенно в отношении субклинических эпизодов. Сложности вызывает и включение смешанных эпизодов, которые не вписываются в бинарную модель «депрессивной» или «маниакальной» преобладающей полярности. Также существенная доля пациентов не демонстрирует выраженной полярности, что затрудняет использование классификации.

С учетом указанных проблем G. Fico et al., был проведён обзор клинических и нейробиологических данных, подтверждающих преобладающую полярность как валидный спецификатор течения биполярного расстройства.

Концептуализация и операционализация преобладающей полярности

Первый подход, называемый «Барселонским предложением», рассматривает полярность расстройства как определённую, если не менее двух третей всех аффективных эпизодов в течение жизни относятся к одной и той же полярности. Этот критерий хорошо валидирован и широко используется в клинической практике.

Второй подход, известный как «Гарвардское предложение», относит пациента к той полярности, на которую приходится простое большинство эпизодов (более 50%). Этот критерий позволяет определить преобладающую полярность у большего числа пациентов, однако характеризуется меньшей диагностической стабильностью и хуже соответствует клиническим коррелятам.

Несмотря на признанность Барселонского подхода, он также подвергается критике. Во-первых, при его применении около половины пациентов попадают в категорию неопределённой преобладающей полярности, что ассоциируется с тяжелым, трудноконтролируемым течением. Во-вторых, преобладающая полярность не учитывает смешанные эпизоды.

DSM-IV определял смешанный эпизод как состояние, при котором одновременно соблюдаются критерии депрессивного и маниакального эпизода. DSM-5 заменил это определение спецификатором «со смешанными признаками». Недавно предложена стратегия учёта смешанных эпизодов: пороговое значение 22,8% смешанных эпизодов от общего числа аффективных эпизодов позволяет выделить специфический смешанный фенотип, ассоциированный с диагнозом биполярного расстройства I типа, повышенным суицидальным риском, самоповреждающим поведением и большим числом аффективных эпизодов.

Клинические корреляты преобладающей полярности

Рабочая группа Международного общества по биполярным расстройствам (ISBD) признала преобладающую полярность валидным спецификатором течения биполярного расстройства. Несмотря на накопленные данные, в DSM-5-TR данный спецификатор отсутствует. Тем не менее международные рекомендации учитывают преобладающую полярность при формировании стратегии долгосрочного лечения.

биполярного расстройства I типа и психотические симптомы. Маниакальная преобладающая полярность ассоциирована с худшими когнитивными исходами, что подчеркивает вклад маниакальных эпизодов в нейропрогрессию. Сопутствующее употребление психоактивных веществ до первого эпизода чаще встречается при маниакальной преобладающей полярности.

Смешанная преобладающая полярность ассоциирована с быстрыми циклами, суицидальными попытками, психотическими симптомами, а также лучшими когнитивными показателями по сравнению с маниакальной и депрессивной. Ее также связывают с сезонностью и агрессивным поведением — признаками смешанного фенотипа.

Фармакотерапия биполярного расстройства с учетом преобладающей полярности

Преобладающая полярность играет ключевую роль в выборе терапевтической стратегии. Отличия между пациентами с преимущественно маниакальным и преимущественно депрессивным течением определяют необходимость персонализированной фармакотерапии. Один из инструментов – «индекс полярности», который отражает соотношение эффективности профилактики депрессивных и маниакальных эпизодов.

При депрессивной преобладающей полярности более предпочтительны ламотриджин и луразидон, а также может потребоваться адъювантная антидепрессивная терапия. При маниакальной преобладающей полярности лучшую эффективность демонстрируют атипичные антипсихотики: рисперидон, арипипразол, зипрасидон, оланзапин. Литий и кветиапин одинаково эффективны в профилактике обеих полярностей и полезны при смешанном фенотипе.

Читать материал полностью на сайте Гедеон Рихтер

Перевод: Щепкин Е.С.

Редактура: Касьянов Е. Д.

« Previous Post: Началась ли эра мускариновых препаратов при шизофрении?

Next Post: «Внутренние» и «внешние» голоса: концептуальная путаница в изучении слуховых вербальных галлюцинаций »